

Relations entre l'industrie pharmaceutique et les professionnels de santé : France, États-Unis, Inde

Analyse comparative des approches de régulation

Antonia TORINESI Olivier CARON

26 mai 2025

Mineure Action Publique - Systèmes de santé et régulation de l'accès au marché



Le scandale du Mediator

1976

Mise sur le marché du Mediator, anti-diabétique des laboratoires Servier

1999

Premier dysfonctionnement des valves cardiaques décelé

2009

La pneumologue Irène Frachon évoque des lésions liées au médicament après une "étude cas-témoins" au CHU de Brest

30 novembre 2009

Retrait du médicament en France, cinq ans après l'Espagne et l'Italie

21 septembre 2011

J. Servier et son groupe mis en examen (homicides involontaires et escroquerie)

19 mars 2013

L'ANSM* mise en examen (homicides et blessures involontaires)

16 avril 2014

Décès de Jacques Servier

22 octobre 2015

La responsabilité civile des laboratoires Servier reconnue pour la 1^{ère} fois (TGI de Nanterre)

20 septembre 2017

La Cour de cassation confirme la responsabilité de Servier

10 octobre 2017

L'État condamné pour la 1^{ère} fois à indemniser une plaignante

Prescrit pendant 33 ans à 5 millions de personnes en France

À l'origine de 1 520 à 2 100 décès (expertise judiciaire)

Servier a indemnisé 3 732 patients pour 131,8 millions € (au 30 août 2019)

23 septembre 2019

Procès contre Servier et l'ANSM au tribunal correctionnel de Paris

*Agence nationale de sécurité du médicament



Etats-Unis : Opioides - Purdue Pharma



DOLO UNDER SCRUTINY, DENIES 'BRIBING' BLAMES



Du scandale à la prise de conscience réglementaire ?

Pays	Scandale	Nature du problème	Réaction réglementaire
France	Mediator (Servier, 1976 , retiré du marché en 2009)	Prescription massive hors AMM d'un coupe-faim toxique. Influence des experts, opacité totale.	Loi Bertrand (2011) : transparence obligatoire via la base Transparence Santé ; interdiction des avantages ; réforme de l'ANSM.
États-Unis	Crise des opioïdes – Purdue Pharma OxyContin (1996)	Marketing mensonger de l'OxyContin présenté comme non addictif. Surprescription, dépendance, décès.	Sunshine Act (2010) : base Open Payments ; divulgation publique des liens ; poursuites judiciaires.
Inde	Dolo-650 – Micro Labs (2020)	Cadeaux massifs aux médecins pour stimuler les prescriptions. Absence de contrôle public.	Code UCPMP 2024 : tentative d'autorégulation contraignante ; interdiction des cadeaux, sans base publique claire.

! Problématique

Comment les États régulent-ils les conflits d'intérêts entre les professionnels de santé et l'industrie pharmaceutique, et quels modèles de transparence et de contrôle produisent-ils ?

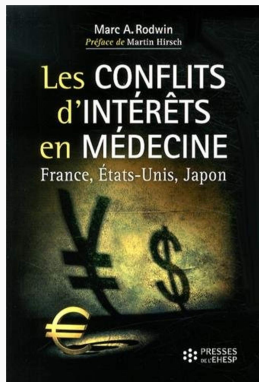
Conflit d'intérêts : quelle définition ?

- Un **conflit d'intérêts (CI)** est une situation dans laquelle deux ou plusieurs intérêts contradictoires affectent une personne et/ou une organisation. Il ne s'agit pas d'une action inappropriée en soi, mais d'un "état d'être", qui peut ne pas être conscientisé. (Abraham 2010)
- Il est donc important de distinguer l'état de conflit d'intérêts du comportement réel : comme le souligne Sismondo (2008), le terme peut être trompeur, car il suggère à tort qu'une personne en situation de conflit d'intérêts agira nécessairement de manière biaisée.
- Les **formes d'influence** peuvent être subtiles : les "cadeaux", les hospitalités, les contrats de consultant, de recherche, de conférencier créent des liens de réciprocité implicites qui peuvent influencer les décisions et les attitudes des experts envers les entreprises/produits ,etc. (Sismondo 2008 ; Katz, Caplan, et Merz 2010)

Quels cadres théoriques pour analyser ces relations ?

- **Capture réglementaire** (Stigler 1984)
 - Les réglementations censées protéger l'intérêt général peuvent être détournées par les acteurs régulés. L'industrie influence les autorités via le lobbying, l'expertise ou les revolving doors, pour orienter les règles en sa faveur. (conflits d'intérêts tolérés, autorégulation de façade, sanctions faibles)
- **Transparence et gouvernementalité** (Foucault 2011 ; Fung, Graham, et Weil 2007 ; Meijer, 't Hart, et Worthy 2018)
 - La transparence fonctionne comme une technique de gouvernementalité : en exposant les comportements, elle incite à l'auto-discipline sans contrainte directe.
 - Elle vise à renforcer la responsabilité (accountability) des médecins (regard des pairs, patients, autorités), mais reste inefficace si l'information est illisible ou inutilisée.

Des cadres politiques et institutionnels variés – France (Rodwin et al. 2014)



- **Forte autorégulation** par le corps médical (Ordre, syndicats), qui freine historiquement l'intervention de l'État dans la régulation des pratiques libérales.
- L'État reste toutefois présent via un **puissant secteur hospitalier public**. Les liens entre médecins et industrie sont **encadrés mais persistent**.
- Comme le rappelle le Conseil constitutionnel (Tabuteau 2023), le système de santé français s'est construit sur des **libertés médicales étendues** :
 - liberté d'installation,
 - liberté de prescription,
 - liberté de tarification,
 - perçues historiquement comme des garanties de l'indépendance professionnelle.
- Toutefois, ces libertés font aujourd'hui l'objet d'un **encadrement progressif**, justifié par des objectifs de santé publique et d'égal accès aux soins.

Réflexion sur les libertés médicales... par un ancien régulateur

Mediator: l'accablement du premier directeur de l'Agence du médicament

AFP

Publié le 19/11/2019 à 23h21



Mediator: l'accablement du premier directeur de l'Agence du médicament © AFP/Archives

Temps de lecture : 3 min

[Ajouter à mes favoris](#)

[Google News](#)

[Commenter](#)

[Partager](#)

Didier Tabuteau est "accablé" depuis qu'a éclaté le scandale Mediator: ce haut fonctionnaire, premier directeur de l'Agence du médicament, en poste entre 1993 et 1997, admet avoir raté les alertes qui auraient pu conduire au retrait du marché de ce coupe-faim pour éviter "le drame".

Procès du Mediator. Le premier directeur de l'Agence du médicament dit son accablement

Didier Tabuteau, premier directeur de l'Agence du médicament, en poste entre 1993 et 1997, a témoigné, ce mardi, lors du procès du Mediator de son accablement. Il admet avoir raté les alertes qui auraient pu conduire au retrait du marché de ce coupe-faim pour éviter « le drame ».

📌 Ouest-France avec AFP
avec AFP
Publié le 19/11/2019 à 21h18

Abonnez-vous

[LIRE PLUS TARD](#)

[IMAGES](#)

Newsletter
Médecine et Santé
Chaque semaine, une sélection de contenus pour mieux comprendre l'actualité de la santé.



Utilisé par cinq millions de personnes pendant les 33 ans de sa commercialisation, le Mediator est tenu pour responsable de centaines de morts. | ARCHIVES JOEL LE GALL/QUEST-FRANCE

Haut fonctionnaire, actuellement président de la section sociale du Conseil d'État, Didier Tabuteau a été le premier directeur de l'Agence du médicament, entre 1993 et 1997. Il était convoqué, ce mardi, en tant que témoin au procès du Mediator.

A la barre

Procès Mediator : une Agence du médicament sans influence

Comment l'anorexigène des laboratoires Servier a-t-il pu rester si longtemps sur le marché alors que plusieurs signaux attestaient des risques ? Les pâles témoignages des directeurs de l'Agence n'ont pas apporté de réponse.



Le jour de l'ouverture du procès du Mediator et des laboratoires Servier, le 23 septembre. (Marc CHAUMEIL/Photo Marc Chaumeil pour Libération)

Une régulation française sous contrainte européenne

- La régulation du médicament en France est également structurée par le cadre européen, qui impose des normes communes à l'ensemble des États membres :/
 - L'**Agence européenne des médicaments (EMA)** délivre les **AMM** pour les médicaments innovants dans toute l'Union européenne, centralisant ainsi une partie de la décision réglementaire.
 - Le **règlement 536/2014** impose la **publication des essais cliniques** via le **Clinical Trials Information System (CTIS)**, renforçant la transparence des données scientifiques utilisées pour les AMM.
 - L'Union européenne encadre également les **conflits d'intérêts dans les agences** (EMA, EFSA...), notamment depuis les critiques formulées après les crises sanitaires liées à la grippe H1N1 et à l'affaire Mediator.
 - La **Direction générale de la concurrence (DG COMP)** a mené plusieurs enquêtes sur les **pratiques anticoncurrentielles de l'industrie pharmaceutique** (ex. stratégies de type *pay for delay*), ce qui a produit un **effet régulateur indirect**, en incitant les entreprises à plus de conformité.

- **Logique de marché dominante** dans l'organisation des soins.
- L'**American Medical Association (AMA)** a longtemps défendu l'autonomie des médecins contre toute régulation externe.
- Le **secteur privé** joue un rôle croissant dans la régulation des pratiques médicales, notamment :
 - les assureurs,
 - les organisations de soins intégrés (Health Maintenance Organizations = HMO),
- Cette régulation privée se fait **parfois au détriment de l'intérêt clinique**.
- Le **pouvoir public reste relativement faible** dans ce domaine.

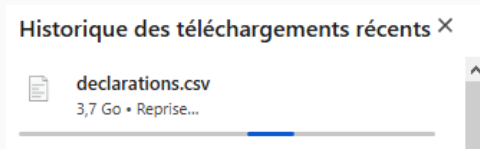
Des cadres politiques et institutionnels variés – Inde (Bhat 1996 ; Mudur 2004 ; Baru 2013)

- **Essor rapide du secteur privé** dans un contexte de régulation **faible et morcelée**.
- Plusieurs lois existent :
 - *Medical Council Act*,
 - *Consumer Protection Act*, etc., mais leur mise en œuvre est **largement déficiente**.
- La *National Medical Commission* (créée en 2019) a remplacé un Conseil médical **entaché de corruption**, sans changement structurel majeur.
- Les **conflits d'intérêts** restent omniprésents dans :
 - la formation médicale,
 - la prescription,
 - les essais cliniques.
- La faiblesse des inspections, **absence de transparence publique**, et influence persistante des **lobbys médicaux** rendent la régulation largement **inefficace**, malgré la croissance du secteur.

Réglementations et dispositifs de transparence

Aspect	France (Loi Bertrand, anti-cadeaux)	États-Unis (Sunshine Act)	Inde (Code UCPMP)
Nature du dispositif	Transparence + interdiction partielle des cadeaux	Transparence uniquement (déclaration publique)	Code déontologique sans transparence publique
Base légale	Loi Bertrand (2011), loi anti-cadeaux (1993, réformée en 2017, appliquée en 2020)	ACA, Sec. 6002 (2010, Physician Payments Sunshine Act)	Directive du Department of Pharmaceuticals (pas de loi formelle)
Champ d'application	Entreprises de santé + tous les bénéficiaires (professionnels, étudiants, associations)	Fabricants + médecins, hôpitaux et désormais assistants médicaux (Medicare/Medicaid)	Entreprises adhérentes + tous pros de santé (public & privé)
Obligations	Déclaration semestrielle >10 € (Transparence Santé); contrats notifiés au CNOM (mais pas publiés)	Déclaration annuelle >\$10 ou >\$100/an (Open Payments)	Registres internes; mécanisme de plainte; pas de base publique
Interdictions	Cadeaux interdits sauf exceptions (recherche, congrès); hospitalité encadrée	Aucune interdiction générale; sanctions possibles via lois anti-corruption	Cadeaux et sponsoring interdits, mais sans seuil national clair
Contrôle	Ministère de la Santé (publication), CNOM (déontologie), DGCCRF/Justice (sanctions)	CMS (collecte), Department of Justice & HHS-OIG (fraude, sanctions)	Department of Pharmaceuticals (code), comités d'éthique industriels, NMC (déontologie)

Transparence : les outils en France



Recherche de données de transparence

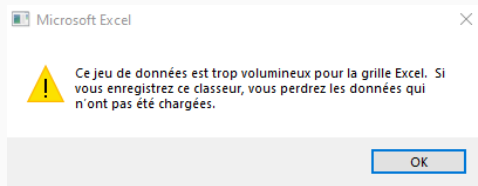
Agnès Firmin Le Bodo

Catégorie du bénéficiaire Profession du bénéficiaire Secteur d'activité de l'entreprise Commune du bénéficiaire

Aucune catégorie sélectionnable Aucune profession sélectionnable Aucun secteur sélectionnable Aucune commune sélectionnable

Bénéficiaires (0 résultat) Entreprises (0 résultat)

Il n'y a pas de résultats pour votre recherche.



La base de données publique Transparence - Santé

La base de données publique Transparence - Santé rend accessible les informations concernant les conventions, les rémunérations et les avantages liés aux entreprises et les acteurs du secteur de la santé. Pilotée par le Ministère des Solidarités et de la Santé, cette initiative de transparence vise à préserver la nécessaire relation de confiance entre les citoyens, les usagers et les multiples acteurs du système de santé. Ce sont les entreprises qui déclarent les informations publiques.

Pour consulter ces informations, vous pouvez :

- Utiliser la recherche rapide : saisissez le nom d'un bénéficiaire ou d'une entreprise dans la barre de recherche ci-dessous,
- Utiliser la page Recherche avancée.

Recherche de données de transparence

Gisclél Claude

Catégorie du bénéficiaire Profession du bénéficiaire Secteur d'activité de l'entreprise Commune du bénéficiaire

Aucune catégorie sélectionnable Aucune profession sélectionnable Aucun secteur sélectionnable Aucune commune sélectionnable

Bénéficiaires (0 résultat) Entreprises (0 résultat)

Il n'y a pas de résultats pour votre recherche.

Transparence : les outils aux Etats-Unis

OpenPaymentsData.CMS.gov Datasets > Summary Data > About >



**OPEN
PAYMENTS**

Learn about the financial relationships
that drug and medical device companies
have with healthcare providers.

[Learn more about Open Payments >](#)

Search by:

☒ Individual Provider ☐ Teaching Hospital ☐ Company

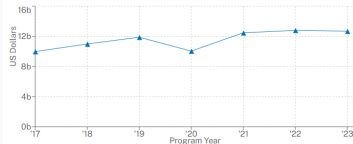
[Search the Data →](#)

Data displayed is from January 2017 - December 2023. [Advanced Search](#)

National Data at a Glance

Showing:

Total Payments over time (USD) ▾



Total Summary

Year:

All Years ▾

Total US Dollar Value

\$ 72,43 Billion

Total Records Published

84,04 Million

[Visit the Payments Overview](#)

Limites des dispositifs de transparence 1/2

Aspect	France	États-Unis	Inde
Type de trans- pa- rence	Base publique (Transparence Santé)	Open Payments (CMS.gov)	Code UCPMP 2024 : code d'autorégulation sans force légale, publié par le Department of Pharmaceuticals (Chaliha 2024 ; Nishith Desai Associates 2025)
Problèmes sou- levés	Base jugée plus accessible que d'autres en Europe mais avec des données peu lisibles avec une qualité variable. L'absence d'identifiants uniques et une sous-déclaration liée au consentement des bénéficiaires (Ozieranski et al. 2021)	Faible usage par les patients biais d'auto-déclaration effets pervers possibles (Chao et Larkin 2020 ; Kanter et al. 2019)	Absence de base publique de divulgation. Dépenses publiées sur les sites des entreprises uniquement. Transparence partielle sans vérification centralisée ni audit indépendant (Chaliha 2024 ; Nishith Desai Associates 2025)
Effets me- su- rés	Impact incertain sur les comportements individuels mais forte utilisation par les journalistes les ONG et les citoyens comme outil de mobilisation et de politisation (Hauray 2018)	Baisse des prescriptions après divulgation (Chao et Larkin 2020) (−4 % au Massachusetts) Efficacité accrue avec interdiction de cadeaux (King et Bearman 2017) (réduction de 39 à 83 % avec interdiction vs divulgation seule). A permis d'établir une association entre paiements de l'industrie et prescriptions de médicaments coûteux, mais n'a pas significativement augmenté la connaissance par les patients des liens financiers de leurs médecins. (Sharma et al. 2018 ; Kanter et al. 2019)	Effet limité du code UCPMP avant 2024. Impact réel encore incertain, influence persistante des pratiques promotionnelles malgré les nouvelles restrictions (Chaliha 2024)

Limites des dispositifs de transparence 2/2 - limites structurelles

France	États-Unis	Inde
Autorégulation implicite du milieu médical. Pouvoir des insiders difficile à exclure (Abraham 2010)	Données agrégées ou lacunaires. Dans certains cas, concentration des paiements (Lo et Grady 2017)	Système juridiquement non contraignant présenté comme quasi obligatoire. Mise en œuvre reposant sur les associations professionnelles. Absence de supervision publique directe (Nishith Desai Associates 2025 ; Chaliha 2024)

- Modèle simplificateur (Stigler 1984) : suppose que les régulateurs sont « achetés » dès que c'est rentable.
- Néglige les contre-pouvoirs (ONG, journalistes, justice) et les mobilisations citoyennes.
 - Ignore les formes « molles » d'influence (langage, normes, réseaux).
 - Théories de l'agenda-setting : pourquoi certains scandales deviennent des leviers de réforme ? (McCOMBS et Shaw, s. d.)
- *Advocacy Coalition Framework* (Sabatier 1988) : coalitions entre industrie, experts et politiques.

- Cette analyse comparative montre que les scandales sanitaires (Mediator, opioïdes, Dolo-650) ont joué un rôle de déclencheur, révélant des **formes diverses de capture réglementaire** dans chaque pays.
- **Trois trajectoires nationales** se dégagent :
 - **France** : transition d'un modèle d'autorégulation médicale vers une régulation publique renforcée après 2010. Les réformes ont permis un encadrement partiel mais réel des conflits d'intérêts.
 - **États-Unis** : mise en place d'une transparence robuste (Open Payments), mais sans interdictions fortes. Le poids du marché limite l'efficacité de la régulation, malgré les contre-pouvoirs judiciaires et médiatiques.
 - **Inde** : échec d'une régulation volontaire longtemps dominée par l'industrie. La réforme du code UCPMP en 2024 marque un tournant, mais reste à consolider.

Conclusion 2/3 France - Etats-Unis

- Les différences de régulation s'expliquent aussi par des **facteurs institutionnels profonds** et des **trajectoires historiques singulières** :
 - **En France**, héritière d'un **État centralisé et juridico-administratif**, la régulation s'inscrit dans une tradition de gouvernement par la haute fonction publique. La **noblesse d'État** (selon l'expression de Pierre Bourdieu ou la notion de "société de cour" d'Edward N. Eisenstadt) structure un pouvoir **technocratique** qui confère à la régulation une **dimension légitime, experte et étatique**. Cela favorise l'émergence d'agences publiques puissantes comme l'ANSM ou la HAS.
 - **Aux États-Unis**, la logique dominante est celle du **marché et de la responsabilité individuelle**. Le pouvoir de l'État fédéral est limité, mais la tradition de **transparence institutionnelle** est forte (Freedom of Information Act, déclassification des archives, transparence des salaires publics...). Cette culture du "Sunshine Government" facilite l'acceptabilité sociale de dispositifs comme **Open Payments**, même si l'interdiction formelle reste politiquement difficile.(Fung, Graham, et Weil 2007 ; Schudson 2015)

L'État souffre d'une **faible capacité administrative**, aggravée par des inégalités structurelles (système des castes, accès différencié aux soins) et une **corruption endémique** dans certains segments de l'administration sanitaire. Les priorités restent le **développement des infrastructures** et l'augmentation des moyens, avant même de penser une régulation stricte. L'autorégulation y a longtemps été une illusion.

Conclusion 3/3

- Finalement, réguler les conflits d'intérêts ne repose pas seulement sur la technique juridique. Cela dépend :
 - des **capacités institutionnelles de l'État**,
 - des **normes professionnelles dominantes**,
 - et des **valeurs politiques collectives** (transparence, confiance, efficacité administrative).
- **La transparence seule ne suffit pas.** Si elle contribue à la responsabilisation, son efficacité dépend de :
 - la lisibilité et l'accessibilité des données,
 - l'existence de sanctions,
 - l'engagement des contre-pouvoirs (journalistes, ONG, justice),
 - la culture administrative et professionnelle nationale.

- Cette analyse plaide pour une régulation **plus partenariale, plus lisible et plus contraignante**, qui tienne compte :
 - des réalités socio-économiques locales,
 - du poids des institutions professionnelles,
 - et de l'impératif de protection de la santé publique dans un marché mondialisé.

- **Formes de capture** (Carpenter et Moss 2013)

Type de capture	Définition
Capture culturelle	Les régulateurs adoptent les valeurs ou idées de l'industrie, souvent inconsciemment (proximité sociale, réseaux, vision partagée de l'innovation).
Capture corrosive	L'industrie affaiblit délibérément la capacité d'action des régulateurs (pressions politiques, attaques publiques, réduction de moyens).
Capture faible	La régulation reste partiellement efficace malgré l'influence des intérêts privés.
Capture forte	La régulation est tellement biaisée qu'elle ne sert plus l'intérêt public. Mieux vaut la réformer ou l'abandonner.

Evaluer les formes de capture : une lecture comparative des réglementations

Forme de capture	France	États-Unis	Inde
Capture culturelle	Faible : forte connivence historique entre experts, Ordre des médecins et industrie. Mais depuis Mediator (2010), émergence d'une culture de vigilance (réforme ANSM, débats publics, journalisme d'investigation).	Faible à forte : idéologie pro-marché internalisée par les agences (FDA, CMS). Le Sunshine Act n'a pas modifié la vision dominante d'une régulation centrée sur l'innovation. La crise des opioïdes a révélé les limites de cette vision, mais les contre-pouvoirs restent actifs.	Forte : alignement structurel entre régulateurs et industrie. La santé publique est subordonnée aux intérêts économiques. La tolérance sociale envers les pratiques promotionnelles reste élevée.
Capture corro-sive	Faible : l'industrie a exercé une influence discrète avant 2011, mais les réformes post-Mediator (ANSM, loi Bertrand) ont restauré une capacité d'action institutionnelle crédible.	Forte : recours massif au lobbying et aux attaques judiciaires contre les agences ; stratégies dilatoires face aux sanctions (ex : Purdue Pharma). L'affaiblissement des régulateurs est délibéré et documenté.	Forte : absence prolongée de cadre légal contraignant jusqu'en 2024. Le lobbying a retardé toute réforme significative. Les agences ont peu de moyens, peu de pouvoir, et peu de légitimité publique.
Niveau global de capture	Faible : la régulation actuelle (Transparence Santé, interdictions partielles, sanctions récentes) limite les conflits d'intérêts sans les éliminer. Résistance du corps médical sur certains leviers (ex : FMC, congrès), mais bénéfice net pour l'intérêt public.	Faible (limite forte) : transparence réelle (Open Payments), mais régulation permissive. L'absence d'interdiction favorise le maintien de liens financiers importants. Impact limité mais réel sur la responsabilisation.	Forte : avant 2024, la régulation était une façade sans effet. La réforme du code UCPMP reste non contraignante dans les faits. Le système demeure dominé par l'autorégulation et les conflits d'intérêts non encadrés.

- Abraham, John. 2010. « On the Prohibition of Conflicts of Interest in Pharmaceutical Regulation : Precautionary Limits and Permissive Challenges. A Commentary on Sismondo (66 :9, 2008, 1909–14) and O'Donovan and Lexchin ». *Social Science & Medicine* 70 (5) : 648-51. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.09.059>.
- Baru, RamaV. 2013. « Challenges for Regulating the Private Health Services in India for Achieving Universal Health Care ». *Indian Journal of Public Health* 57 (4) : 208. <https://doi.org/10.4103/0019-557x.123243>.
- Bhat, Ramesh. 1996. « REGULATION OF THE PRIVATE HEALTH SECTOR IN INDIA ». *The International Journal of Health Planning and Management* 11 (3) : 253-74. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1099-1751\(199607\)11:3%3C253::aid-hpm435%3E3.0.co;2-n](https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1751(199607)11:3%3C253::aid-hpm435%3E3.0.co;2-n).

- Carpenter, Daniel, et David A. Moss, éd. 2013. *Preventing Regulatory Capture : Special Interest Influence and How to Limit it*. Cambridge : Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139565875>.
- Chaliha, Akankshya. 2024. « Policy Analysis and Impact Assessment on UCPMP 2024 ». <https://www.linkedin.com/pulse/policy-analysis-impact-assessment-ucpmp-2024-akankshya-chaliha-6w5yc>.
- Chao, Matthew, et Ian Larkin. 2020. « Regulating Conflicts of Interest Through Public Disclosure : Evidence From a Physician Payments Sunshine Law ». *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3539990>.
- Foucault, Michel. 2011. *Surveiller et punir : Naissance de la prison*. Paris : Gallimard.

- Fung, Archon, Mary Graham, et David Weil. 2007. *Full Disclosure : The Perils and Promise of Transparency*. 1^{er} éd. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9780521699617>.
- Hauray, Boris. 2018. « Dispositifs de transparence et régulation des conflits d'intérêts dans le secteur du médicament ». *Revue française d'administration publique* N° 165 (1) : 49-61. <https://doi.org/10.3917/rfap.165.0049>.
- Kanter, Genevieve P, Daniel Carpenter, Lisa Lehmann, et Michelle M Mello. 2019. « Effect of the Public Disclosure of Industry Payments Information on Patients : Results from a Population-Based Natural Experiment ». *BMJ Open* 9 (2) : e024020.
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024020>.

- Katz, Dana, Arthur L. Caplan, et Jon F. Merz. 2010. « All Gifts Large and Small : Toward an Understanding of the Ethics of Pharmaceutical Industry Gift-Giving ». *The American Journal of Bioethics* 10 (10) : 11-17.
<https://doi.org/10.1080/15265161.2010.519226>.
- King, Marissa, et Peter S. Bearman. 2017. « Gifts and Influence : Conflict of Interest Policies and Prescribing of Psychotropic Medications in the United States ». *Social Science & Medicine* 172 (janvier) : 153-62.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.11.010>.
- Lo, Bernard, et Deborah Grady. 2017. « Payments to Physicians : Does the Amount of Money Make a Difference ? » *JAMA* 317 (17) : 1719-20.
<https://doi.org/10.1001/jama.2017.1872>.

- McCOMBS, MAXWELL E, et Donald L Shaw. s. d. « The Agenda-Setting Function of Mass Media ».
- Meijer, Albert, Paul 't Hart, et Ben Worthy. 2018. « Assessing Government Transparency : An Interpretive Framework ». *Administration & Society* 50 (4) : 501-26. <https://doi.org/10.1177/0095399715598341>.
- Mudur, Ganapati. 2004. « Inadequate regulations undermine India's health care ». *BMJ : British Medical Journal* 328 (7432) : 124. <https://doi.org/10.1136/bmj.328.7432.124-a>.
- Nishith Desai Associates. 2025. « Regulatory Wrap 2024 : Pharmaceutical Industry in India ». <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=94899ad2-6d12-423f-b98f-fc1e18878e13>.

- Ozieranski, Piotr, Luc Martinon, Pierre-Alain Jachiet, et Shai Mulinari. 2021.
« Accessibility and Quality of Drug Company Disclosures of Payments to Healthcare Professionals and Organisations in 37 Countries : A European Policy Review ». *BMJ Open* 11 (12) : e053138. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-053138>.
- Rodwin, Marc A., Geneviève Knibiehler, Martin Hirsch, et Dominique Thouvenin. 2014.
Les conflits d'intérêts en médecine : quel avenir pour la santé ? : France, Etats-Unis et Japon. Presses de l'EHESP.
- Sabatier, Paul A. 1988. « An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein ». *Policy Sciences* 21 (2-3) : 129-68.
<https://doi.org/10.1007/bf00136406>.

- Schudson, Michael. 2015. *The Rise of the Right to Know : Politics and the Culture of Transparency, 1945–1975*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674915787>.
- Sharma, Manvi, Aisha Vadhariya, Michael L. Johnson, Zachary A. Marcum, et Holly M. Holmes. 2018. « Association Between Industry Payments and Prescribing Costly Medications : An Observational Study Using Open Payments and Medicare Part D Data ». *BMC Health Services Research* 18 (1) : 236.
<https://doi.org/10.1186/s12913-018-3043-8>.
- Sismondo, Sergio. 2008. « How Pharmaceutical Industry Funding Affects Trial Outcomes : Causal Structures and Responses ». *Social Science & Medicine* 66 (9) : 1909-14. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.01.010>.
- Stigler, George J. 1984. « The Theory of Economic Regulation ». In. Routledge.

Tabuteau, Didier-Roland. 2023. « Les libertés médicales et l'organisation des soins en France ». *Titre VII*, n 11. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/les-libertes-medicales-et-l-organisation-des-soins-en-france>.